

recording_2026-02-24_20-53-59

Participants

Date 2026-02-24

Overview

Ordine del giorno

- **Valutazione e riconoscimento dell'ictus cerebrale**
- **Monitoraggio continuo durante il trasporto**
- **Gestione del dolore toracico e sospetto infarto**
- **Elettrocardiogramma (ECG): utilizzo e limiti**
- **Shock cardiogeno e alterazioni circolatorie**
- **Aritmie cardiache: veloci e lente**
- **Chiamata prioritaria alla centrale operativa**
- **Importanza della valutazione sul campo**

Argomenti discussi

Valutazione e riconoscimento dell'ictus cerebrale

L'istruttore ha sottolineato l'importanza di determinare il tempo di insorgenza dei sintomi, fondamentale per la terapia trombolitica (finestra di 3 ore). È essenziale raccogliere informazioni sull'ultimo momento in cui il paziente era asintomatico e portare la documentazione sanitaria più aggiornata possibile. La valutazione CPSS è positiva anche con un solo sintomo presente.

Monitoraggio continuo durante il trasporto

È stato ribadito che la valutazione deve essere continua per tutta la durata del trasporto. Gli operatori devono monitorare costantemente polso, pressione, saturimetria, temperatura, colorito cutaneo e intensità del dolore.

Gestione del dolore toracico e sospetto infarto

Ogni dolore toracico deve essere trattato come potenziale infarto fino a esclusione ospedaliera. Anche sintomi atipici (dolore addominale, dolore che cambia con la pressione)

vanno considerati seriamente. Il principio guida è "in caso di dubbio, pensare sempre al peggio" e indirizzare il paziente verso un ospedale con cardiologia.

Elettrocardiogramma (ECG): utilizzo e limiti

L'ECG non fornisce un quadro completo della salute cardiaca e non autorizza a lasciare il paziente a domicilio. Gli operatori non devono interpretare l'ECG né basare decisioni di trasporto sui risultati automatici. Se il paziente rifiuta il trasporto dopo l'ECG, va richiamata la centrale e informati i familiari.

Shock cardiogeno e alterazioni circolatorie

Lo shock si verifica quando c'è squilibrio tra apporto di sangue ai tessuti e necessità di ossigeno. I segni includono sudorazione fredda e pallore cutaneo, causati dalla ridotta perfusione periferica. Se non trattato tempestivamente, può evolvere verso esiti fatali.

Aritmie cardiache: veloci e lente

Le aritmie veloci (>120 bpm) e lente (

Chiamata prioritaria alla centrale operativa

In presenza di segni/sintomi che compromettono le funzioni vitali, la chiamata prioritaria è essenziale. Permette di ricevere istruzioni aggiuntive dal medico/infermiere e di identificare tempestivamente la struttura ospedaliera appropriata.

Importanza della valutazione sul campo

La valutazione degli operatori è fondamentale per indirizzare correttamente il paziente e allertare l'ospedale. L'ECG sul campo permette valutazioni ulteriori e ottimizza il percorso di cura. Ictus e problematiche cardiocircolatorie rappresentano le emergenze più frequenti oltre ai traumi.

Azioni

- **Operatori:** Raccogliere sempre il tempo di insorgenza dei sintomi o l'ultimo momento in cui il paziente era asintomatico durante interventi per sospetto ictus. *Applicazione immediata su tutti i servizi*
- **Operatori:** Mantenere monitoraggio continuo dei parametri vitali durante tutto il trasporto (polso, pressione, saturimetria, temperatura, colorito, dolore). *Applicazione immediata*
- **Operatori:** Portare sempre la documentazione sanitaria più aggiornata disponibile. *Applicazione immediata*
- **Operatori:** Effettuare chiamata prioritaria alla centrale in presenza di segni/sintomi che compromettono le funzioni vitali. *Applicazione immediata*
- **Operatori:** Non interpretare autonomamente l'ECG né utilizzarlo per decidere se lasciare il paziente a domicilio. *Applicazione immediata*
- **Operatori:** Trattare ogni dolore toracico come potenziale infarto e indirizzare verso ospedale con cardiologia. *Applicazione immediata*

- **Operatori:** Mantenere il paziente con aritmia calmo e a riposo, evitando di comunicare dati allarmanti in sua presenza. *Applicazione immediata*

Approfondimenti

Problema: Difficoltà nella raccolta anamnestica con pazienti poco collaborativi o afasici

Soluzione: Riconoscere i limiti della valutazione e documentare ciò che è stato possibile raccogliere. La collaborazione del paziente influenza la completezza dei dati; procedere comunque con la valutazione CPSS che richiede solo un sintomo positivo.

Problema: Rischio di lasciare a domicilio pazienti con ECG apparentemente normale

Soluzione: L'ECG non è diagnostico completo. Non autorizzare permanenza domiciliare basandosi solo sull'ECG. Se il paziente rifiuta il trasporto, richiamare la centrale e informare i familiari. Principio: "ECG fatto = trasporto in ospedale".

Problema: Sottovalutazione di dolori toracici atipici (es. dolore addominale post-prandiale)

Soluzione: Applicare il principio "in caso di dubbio, pensare sempre al peggio". Anche sintomi atipici vanno trattati come potenziale infarto e il paziente va indirizzato verso ospedale con cardiologia.

Problema: Difficoltà nel rilevare frequenze cardiache molto elevate al polso

Soluzione: Utilizzare il saturimetro per la rilevazione della frequenza cardiaca in caso di tachicardia estrema. Effettuare chiamata prioritaria immediata per ricevere istruzioni e identificare rapidamente la destinazione appropriata.

Problema: Aumento dell'ansia del paziente che peggiora l'aritmia

Soluzione: Evitare comunicazioni allarmanti in presenza del paziente. Mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante. Impedire al paziente di camminare o sforzarsi.

Problema: Ritardi nell'identificazione della struttura ospedaliera appropriata

Soluzione: Effettuare chiamata prioritaria tempestiva che permette alla centrale di iniziare immediatamente la ricerca del posto corretto e di fornire istruzioni aggiuntive agli operatori.